慢性阻塞性肺疾病中医诊疗指南

（2018 修订版）

编制说明提纲

《慢性阻塞性肺疾病中医诊疗指南（2018 修订版）》修订小组

二〇一八年十月

目 录

一、 背景介绍.....2
（一） 任务背景.....2
（二） 任务来源与参加单位.....2
二、 专家委员会及工作组.....3
（一） 指南指导委员会.....3
（二） 本共识方法学专家.....3
（三） 领域专家（共识）委员会.....4
（四） 工作组.....4
1. 首席专家.....4
2. 系统评价组.....4
3. 执笔人.....4
4. 秘书处.....4
三、 主要工作过程.....4
（一） 启动部署阶段.....4
（二） 起草阶段.....5
1. 指南修订计划的制定和实施步骤的落实.....5
2. 组织管理.....5
3. 避免利益冲突.....6
4. 确定指南修订的主题和目的，制定修订计划.....7
5. 根据 PICO 确定检索策略 8
6. 针对各结局对证据体进行质量评价.....8
7. 名义组法会议..... 8
8. 证据汇编存档.....9
（三） 征求意见阶段（见同行意见征求表）.....9
四、 标准编制的原则.....9
五、 技术内容的确认方法与依据.....9
（一） 总体内容.....9
（二） 内容分解.....9
六、 与相关法律、法规和强制性标准的关系.....10
七、 重大分歧意见的处理经过和依据.....10
八、 作为强制性标准或推荐性标准的建议.....10
九、 贯彻标准的要求和措施建议.....10
十、 废止现行有关标准的建议.....10
十一、附件.....10

一、背景介绍

（一） 任务背景

慢性阻塞性肺疾病（Chronic Obstructive Pulmonary Disease，COPD）是一种常见的、可以预防和治疗的疾病，以持续呼吸症状和气流受限为特征，通常是由于明显暴露于有毒颗粒或气体引起的气道和/或肺泡异常所导致。COPD 最常见的症状为咳嗽、咳痰、呼吸困难，在其病程中常出现急性加重，急性加重是促进疾病持续进展、导致额外治疗的主要因素。COPD 主要累及肺脏，但大多数患者存在重大的共患慢性疾病，增加 COPD 的致残率和死亡率。目前 COPD 居全球死亡原因的第 4 位，预计 2020 年将成为全球致死原因第 3 位和经济负担的第 5 位。全球 COPD 的总体患病率约为 11.7%，每年约有 350 万人死于 COPD，世界卫生组织预计到 2030 年全球每年约有超过 450 万人死于 COPD 和其相关疾病。2012～2014 年我国 40 岁以上人群的 COPD 患病率约为 13.7%，COPD 排在我国疾病死亡原因的第 3 位，我国 COPD 的死亡率及疾病负担均高于全球平均水平。COPD 多属于中医学的“咳嗽”、“喘病”、“肺胀”等范畴。

为进一步完善诊疗规范，促进中医诊治 COPD 水平的提高，2011 年国家中医临床研究基地重点病种（慢阻肺）建设项目组组织专家，按照国际相关指南研制规范，制定了《慢性阻塞性肺疾病中医诊疗指南（2011 年版）》。2011 年以来，国际学术界对 COPD 的认识发生了新的变化，并对相关指导性文件进行了重要修订。同时，我国中医药防治 COPD 的临床研究也取得了一些新的成果。为了及时反映国内外研究进展，更好地指导我国 COPD 的中医临床诊疗工作，中华中医药学会肺系病分会联合中国民族医药学会肺病分会组织成立了由中医或中西医结合临床和基础研究、临床流行病学、循证医学、卫生经济学、药剂学等多学科人员组成的《慢性阻塞性肺疾病中医诊疗指南（2018 修订版）》修订小组，参照 2011 版《慢性阻塞性肺疾病中医诊疗指南》，依据临床实践指南更新规范（Checklist for the Reporting of Updated Guidelines, CheckUp）、指南报告规范-RIGHT 标准的要求，以循证医学思想为指导，注重中医特色，对现有的相关证据进行了充分收集和评价，编写成本指南，以期能够为从事 COPD 防治的中医、中西医结合临床医师提供指导性意见。

（二）任务来源与参加单位

项目资助及来源：国家“万人计划”百千万工程领军人才（W02060076）、2015年度中医药行业科研专项（201507001-01）、国家中医药管理局国家中医临床研究基地业务建设科研专项（JDZX2015152）的基金支持。

参与起草单位（按地理区域排序）：中国中医科学院中医临床基础医学研究所、北京中医药大学循证医学中心、中日友好医院、北京大学人民医院、中国中医科学院西苑医院、北京中医药大学东方医院、中国中医科学院广安门医院、天津中医药大学第二附属医院、山西省中西医结合医院、辽宁中医药大学附属第二医院、黑龙江中医药大学附属第一医院、上海中医药大学附属龙华医院、上海中医药大学附属曙光医院、江苏省中医院、浙江省中医院、安徽中医药大学第一附属医院、福建中医药大学附属第二人民医院、漳州市中医院、江西中医药大学附属医院、山东中医药大学附属医院、河南中医药大学第一附属医院、河南省人民医院、河北省中医院、广东省中医院、广州中医药大学第一附属医院、四川大学华西医院、成都中医药大学、贵阳中医学院第二附属医院、昆明市中医医院、陕西省中医医院、宁夏医科大学、新疆维吾尔自治区中医医院。

二、专家委员会及工作组

（一） 指南指导委员会

顾　　问：王永炎　中国中医科学院

张伯礼　天津中医药大学

晁恩祥　中日友好医院

孙塑伦　国家中医药管理局

组　　长：李建生　河南中医药大学

谢雁鸣　中国中医科学院中医临床基础医学研究所

副 组 长：李素云　河南中医药大学第一附属医院

余学庆　河南中医药大学第一附属医院

（二） 方法学专家

谢雁鸣　中国中医科学院中医临床基础医学研究所

刘建平　北京中医药大学循证医学中心

杨克虎　兰州大学循证医学中心

詹思延　北京大学循证医学中心

胡镜清　中国中医科学院中医基础理论研究所

张俊华　天津中医药大学循证医学中心

陈　薇　北京中医药大学循证医学中心

廖　星　中国中医科学院中医临床基础医学研究所

（三）　疾病领域专家委员会

马战平、于雪峰、毛　兵、王　飞、王　真、王至婉、王明航、白　丽、冯淬灵、付　义、史利卿、刘良倚、刘敬霞、孙增涛、孙子凯、陈志斌、李风森、李光熙、李素云、李学林、李友林、李泽庚、李竹英、余海滨、余学庆、杨珺超、张海龙、张洪春、张惠勇、张念志、张　伟（山东）、张　炜、张　伟（广东）、张燕萍、林　琳、苗　青、封继宏、洪敏俐、赵丽敏、耿立梅、徐立然、葛正行、鹿振辉、谢　洋、薛汉荣

（四）　工作组

1. 首席专家

李建生　河南中医药大学

2. 系统评价组

陈　薇　北京中医药大学循证医学中心

王明航　河南中医药大学第一附属医院

张海龙　河南中医药大学第一附属医院

李　彬　河南中医药大学第一附属医院

王燕芳　河南中医药大学第一附属医院

3. 执笔人

李建生　河南中医药大学

余学庆　河南中医药大学第一附属医院

4. 秘书处

余学庆　河南中医药大学第一附属医院

谢　洋　河南中医药大学第一附属医院

三、主要工作过程

（一）启动部署阶段

2017 年 6 月 20 日，李健生教授在河南中医药大学第一附属医院召开“2018 慢性阻塞性肺疾病中医诊疗指南”修订项目讨论会，会议确定《慢性阻塞性肺疾病中医诊疗指南（2011 版）》进行修订，以期为中医药诊疗 COPD 临床应用给出切实可行的推荐或建议。工作组基于现有最佳证据、结合专家经验、结合中医药自身特点及我国的实际情况，制订《慢性阻塞性肺疾病中医诊疗指南（2018 修订版）》。为此，李建生教授组建了 8 人小组，李建生教授作为课题的整体顶层设计领导者，成立个工作小组。为了保证研究进度，工作组设立了例会制，定期汇报工作进度，完善方案，加强质量控制，同时制订了 COPD 工作组指南编制时间节点，见图 1。2018 年 5 月下旬在国际指南注册平台进行了双语注册，获得注册号：IPGRP-2018CN029；6 月底获得中华中医药学会团体标准立项。

（二）起草阶段

2017 年 6 月 20 日——2018 年 10 月 20 日

1. 指南修订计划的制定和实施步骤的落实

工作组根据分配的任务，制定指南修订计划，并征求有关专家意见，召开专家讨论会，完善研究计划，并落实指南制定具体实施步骤，起草小组反复讨论，达成内部的共识，征求高层专家意见，对指南的编制内容及计划进行修改完善。实施步骤见下图。

图 1 18 版指南修订流程图

2. 组织管理

本指南设置指导委员会、秘书处、共识专家小组、系统评价小组、起草工作组。指导委员会负责确定指南主题和范围；组建共识专家组和秘书组，

并管理其利益声明；监督指南修订流程；批准推荐意见和指南全文；监测并评估指南的更新需求。秘书处负责全程协调整个指南编撰的组织管理和业务管理工作，详细记录指南修订整个过程；协调指南修订相关事项；协助完成指南外审工作。共识专家小组对于指南修订过程中，有关临床 PICO 的讨论、推荐意见的形成、专家共识的形成都需要共识专家发挥积极作用。系统评价小组负责完成证据的检索和评价，以及 GRADE 的评价。起草工作组负责协助调研临床 PICO 问题；协助完成系统评价、证据分级和形成决策表。

3. 避免利益冲突

本指南所有参与成员均签署利益冲突声明，申明无任何与本部指南主题相关的任何商业的、专业的或其他方面的利益冲突。

4. 确定修订的主题和目的，制定修订计划

本指南是《慢性阻塞性肺疾病中医诊疗指南（2011 版）》的修订版。项目组依据指南更新报告规范的要求，对《慢性阻塞性肺疾病中医诊疗指南（2011 版）》内容进行了全面梳理，确定需修订的范围，并在相关法律法规和技术文件指导的框架下，基于现有最佳证据、结合专家经验、结合中医药自身特点及我国的实际情况，制订《慢性阻塞性肺疾病中医诊疗指南（2018 修订版）》，以期为临床应用给出切实可行的推荐或建议，为从事慢阻肺防治的中医、中西医结合临床医师提供指导性意见，提升中医药防治慢阻肺水平。技术变化主要如下：

与 2011 版指南相比主要技术变化如下：

——拟删除单方验方（见 2011 版的 3.1）；

——拟删除辨证论治中中药剂量的标注（见 2011 版的 2.1-2.2）；

——拟增加疾病分期的急性加重危险窗期；

——拟增加辨证论治中干预措施的循证医学证据等级及推荐强度；

——拟增加急性加重危险窗期辨证论治的建议；

——拟增加临床兼证及复杂证候治疗建议；

——拟增加预防调护；

——拟修改疾病严重程度分级；

——拟修改辨证论治中推荐方剂及中成药；

——修改其他治法（见 7.4）

5. **确定临床问题，根据 PICO 确定检索策略**

检索策略分为电子检索和手工检索。检索内容分为：国内外原始研究数据库。原始研究数据库主要有：①英文：PubMed，Embase 和 Cochrane library。②中文：中国知网（CNKI）、中文科技期刊全文数据库（VIP）、中国生物医学文献数据库（SinoMed）、万方全文数据库（WANFAN DATE）。手工检索了重要古籍、现代相关专著、医疗保险目录、药典等标准化文件。检索时间均从 2012 年至 2017 年 7 月。

中文检索词为：慢性阻塞性, 肺疾病、慢性阻塞性肺疾病、慢性气道阻塞性疾病、慢性气道阻塞性肺病、慢性气道阻塞、慢阻肺、阻塞性肺病、阻塞性肺疾病、慢阻肺；中医、中药、中医药、传统医学、中草药、中西医、中西药、中成药；风寒袭肺、外寒内饮、痰热壅肺、痰湿阻肺、痰蒙神窍、肺气虚、肺脾气虚、肺肾气虚、肺肾气阴两虚等。英文检索词为：pulmonary disease, chronic obstructive、chronic obstructive pulmonary disease、 慢阻肺、 chronic obstructive lung disease、chronic obstructive airway disease、chronic obstructive respiratory disease、chronic bronchitis、chronic emphysema、chronic airflow obstruction；Chinese medicine、traditional Chinese medicine、Chinese herbal medicine、Chinese herbal drug、Chinese plant drug、traditional herbal medicine、herbal medicine、TCM、complementary and alternative medicine。

采用以上检索策略，共获得中文文献 8408 篇文献，英文文献 191 篇文献，结合手工筛选并排除重复的文献，最终筛选出 6617 篇文献。针对以下情况对证据进行初筛、二轮筛选：① 与中医药治疗 COPD 无关；② 中医外治法文献；③ 理论操讨文献；④ 动物实验类文献；⑤ 普通综述；⑥人工读出重复文献；⑦ 护理类文献；⑧ 两种或以上干预措施文献；⑨非随机文献；⑩ 低质量 meta 分析；最终获得 50 篇符合纳入要求，可以进行质量评价的文献。

6. **针对各结局对证据体进行质量评价**

Meta 分析的评价：采用 AMSTAR 量表进行文献质量评价。每个条目评价结果分为“是”、“否”、“不清楚”或“未提及”三种，并给予加分如“是”为 1 分，“否”、“不清楚”或“未提及”为 0 分，共 11 分。AMSTAR 量表得分 0~4 分为低质量，5~8 分为中等质量，9~11 分为高质量。纳入与本指南 PICO 一致的中、高质量的 Meta

分析。对发表年份于 2015 年以前的系统评价，若有新的 RCT 文献则进行更新后纳入。

RCT 文献评价方法：根据 Cochrane 评价手册 Handbook 5.1.0 中的“偏倚风险评估”工具对进行评价：①随机分配方法；②分配方案隐藏；③对研究对象，治疗方案实施者采用盲法；④对研究结果测量者采用盲法；⑤结果数据的完整性；⑥选择性报告研究结果；⑦其他偏移来源。最终对文献做出“偏倚风险低”、“偏倚风险高”、“偏倚风险不确定”的判断。

证据的可信度及推荐强度采用国际统一的 2004 年制订的推荐分级的评估、制定和评价(The Grading of Recommendations Assessment Development and Evaluation, GRADE) 标准。

7. 名义组法实现共识过程

证据综合报告形成：系统检索、筛选中医药治疗 COPD 的文献，按 GRADE 标准对符合 PICO 的 Meta 分析及 RCT 文献进行评价，得出证据级别；并检索相关经典古籍、现代呼吸专著、医保目录、中华人民共和国药典等标准化文件，作为证据补充，形成证据综合报告。

临床专家调研报告：基于证据综合报告基础上，进行 2 轮专家问卷调研（副主任医师以上职称，涉及 17 家医疗单位，覆盖全国 16 个省份和直辖市），第一轮基于证据收集后的干预措施进行评价；第二轮对需要更新版指南编写体例及推荐的中成药进行评价。结合专家调研结果，拟定出推荐方案。最终进行了 38 人次的调研：第一轮 20 名，第二轮 18 名。

药品不良反应及经济学评价信息：充分收集推荐方案中药物说明书或文献中提及药物不良反应信息；将推荐方案与同类药物进行经济学评价对比，并结合患者价值观及偏好，得出推荐方案的经济学信息。

制定推荐意见表：运用 GRADE 网格将推荐意见所基于的证据质量、临床专家调研结果、药品说明书信息、患者偏好与价值观以及相关经济学分析数据信息整合，形成推荐意见表及投票单。

召开名义组会议：①由 13 名共识组专家于 2018 年 2 月 3 日在河南中医药大学第一附属医院召开名义组会议。共识组成员包括：从事呼吸系统疾病诊疗的临床一线中医、西医专家；方法学专家：中医药循证医学方面的专家；临床药师 1

名。②由会议秘书阐述指南更新推荐方案，引导共识组专家阅读推荐意见表的相关信息，共识组专家充分权衡利弊，做出“强推荐”、“弱推荐”、“无明确推荐”、“弱不推荐”、“强不推荐”的判断，并独立填写推荐意见投票单。③统计推荐结果，并达成共识。统计方法如下：若除了“0”以外的任何 1 格票数超过 50%，则视为达成共识，可直接确定推荐意见方向及强度；若“0”某一侧两格总票数超过 70%，亦视为达成共识，可确定推荐方向，推荐强度则直接定为“弱”；其余情况视为未达成共识。未达成共识的推荐意见，将由共识专家阐述意见，会议秘书记录、汇总、写成备注后，进入下一轮投票，经过≥2 轮的投票，最终达成共识。

8. 证据汇编存档

本共识在证据检索、筛选、评价过程整体情况的概述，具体的操作过程及其所产生的本底资料，均进行了汇编，并留存，作为本共识的配套资料，详见本共识的“编制说明”。原始材料均在中华中医药学会进行存档。

（三） 征求意见阶段（见同行意见征表）

四、标准编制的原则

本指南的修订程序、方法、结构，是在借鉴国际上通用的临床实践指南制定方法的基础上，注重中医特色，既要保证指南制订的科学性，又要符合中医疾病临床实际。由于本病的复杂性 ，很多临床中医药治疗多为专家经验，缺乏严格的临床证据，所以本指南的制订，广泛听取专家意见，对指南的整体拟解决的临床问题进行了前期调研和证据检索，做到全有过程和环节有据可循，可以溯源。

另外，本指南的体例结构将严格遵循中华中医药学会团体标准所要求的格式，进行统一规划撰写，力争能够符合要求并顺利通过审核、发布。

五、技术内容的确认方法与依据

（一）总体内容

指南正文共设 10 部分，主要技术内容有范围、规范性引用文件、术语及定义、流行病学特点、诊断、病因病机、辨证论治、其他治法、预防调护、指南修订方法。

（二）内容分解

第 1 部分明确该指南适用范围和适用对象。

第 2 部分列出该指南主要引用的标准规范文件。

第 3 部分规定该指南的术语和定义。

第 4 部分是介绍 COPD 的流行病学特点。

第 5 部分是介绍本病的诊断，包括诊断依据、疾病分期、严重程度评估。

第 6 部分是介绍本病病因病机。

第 7 部分是介绍本病辨证论治，包括急性加重期、急性加重危险窗期、稳定期、临床复杂证候治疗建议。

第 8 部分是介绍 COPD 的其他治法。

第 9 部分是介绍 COPD 的预防和调护。

第 10 部分是介绍了指南修订方法，包括指南修订计划的制订和实施步骤的落实、基金资助及利益冲突、修订指南步骤、修订版指南的发布与更新。

六、与相关法律、法规和强制性标准的关系

与现行的法律、法规和强制性标准没有冲突。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

制订过程中，无重大分歧意见。

八、作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议作为推荐性行业标准发布实施。

九、贯彻标准的要求和措施建议

建议从中华中医药学会的网站，微信平台，论文，培训等贯彻实施、推广应用。

十、废止现行有关标准的建议

十一、附件

附件 1：慢阻肺中医诊疗指南修订-立项申请书

附件 2：慢阻肺-中华中医药学会团体标准研制方案

附件 3：慢性阻塞性肺疾病中医诊疗指南-立项公告

附件 4：慢性阻塞性肺疾病中医诊疗指南-中英文注册证明

附件 5：利益冲突声明

附件 6：需修订章节调研结果和重要结局指标（PICO）

附件 7：现代研究检索式举例及结果

附件 8：COPD 成药药典、医保目录等

附件 9：中医古籍记载、教材及医学著作

附件 10：Meta 分析评价、RCT 评价汇总表

附件 11：GRADE 评级

附件 12.1：COPD 指南更新专家问卷积分统计（第一轮）

附件 12.2：COPD 指南更新专家问卷积分统计（第一轮）

附件 12.3：慢性阻塞性肺疾病中医诊疗指南-更新-第二轮专家咨询汇总版

附件 12.4：COPD 指南更新专家问卷积分统计（第二轮）及第一第二轮综合结果

附件 13.1：COPD 稳定期推荐 GRADE 网格

附件 13.2：COPD 急性加重期推荐 GRADE 网格

附件 14：名义组会议计分表格及结果 2018-02-05